

Série Épilepsies FMSf 2025

Pr Chahnez Charfi Triki

1. Quelle est la cause la plus fréquente de crises focales symptomatiques ?

- A. Lésion structurale corticale
- B. Hypoglycémie
- C. Fièvre
- D. Hyperventilation
- E. Privation de sommeil

Réponse : A

2. Quelle caractéristique distingue une crise épileptique d'une syncope ?

- A. Morsure de la langue latérale
- B. Perte de conscience brève
- C. Chute
- D. Sudation
- E. Récupération rapide

Réponse : A

3. Quelle est la durée habituelle d'une absence typique ?

- A. Moins de 20 secondes
- B. 1 à 2 minutes
- C. 5 minutes
- D. 10 secondes à 2 minutes
- E. Plus de 10 minutes

Réponse : A

4. Quelle anomalie EEG signe une épilepsie autolimitée à pointes centro temporales ?

- A. Pointes centro-temporales bilatérales
- B. Hypsarythmie
- C. Polyspikes frontaux
- D. Ondes lentes occipitales
- E. Activité delta généralisée

Réponse : A

5. Quelle est la particularité clinique de l'épilepsie autolimitée à pointes centro-temporales ?

- A. Crises nocturnes oropharyngées avec hypersalivation
- B. Crises d'absence diurnes prolongées
- C. Spasmes en flexion au réveil
- D. Crises tonico-cloniques matinales
- E. Crises déclenchées par l'hyperventilation

Réponse : A

6. Quelle caractéristique distingue une crise fonctionnelle non épileptique ?

- A. Mouvements asynchrones, durée prolongée, yeux fermés
- B. Chute brutale avec cri
- C. Morsure de la langue latérale
- D. Confusion post-critique
- E. EEG avec pointes-ondes

Réponse : A

7. Quel examen est essentiel pour le diagnostic différentiel entre crises épileptiques et fonctionnelle non épileptique ?

- A. Vidéo-EEG prolongé
- B. IRM cérébrale
- C. Scanner cérébral
- D. Électromyogramme
- E. Potentiels évoqués visuels

Réponse : A

8. Quelle manifestation est typique d'une crise du lobe occipital ?

- A. Phosphènes colorés ou hallucinations visuelles élémentaires
- B. Aura gustative
- C. Rigidité axiale
- D. Automatisme oro-alimentaire
- E. Confusion prolongée

Réponse : A

9. Quelle anomalie EEG est typique des crises d'absence atypiques ?

- A. Pointes-ondes lentes <2,5 Hz
- B. Polyspikes-ondes rapides
- C. Activité delta occipitale
- D. Ondes lentes asymétriques
- E. Activité bêta généralisée

Réponse : A

10. Quelle crise débute souvent par un arrêt du regard et une automatisation ?

- A. Crise temporale mésiale
- B. Crise frontale motrice
- C. Crise occipitale
- D. Crise pariétale
- E. Crise tonique

Réponse : A

11. Quelle est la caractéristique d'une crise atonique ?

- A. Perte brutale du tonus postural
- B. Rigidité axiale
- C. Secousses rythmiques
- D. Aura olfactive
- E. Automatismes oraux

Réponse : A

12. Quelle est la particularité de l'épilepsie myoclonique juvénile ?

- A. Myoclonies matinales déclenchées par le manque de sommeil
- B. Crises uniquement nocturnes
- C. EEG toujours normal
- D. Crises fébriles prolongées
- E. Spasmes en flexion

Réponse : A

13. Quelle encéphalopathie présente des spasmes en flexion suivis de troubles cognitifs sévères ?

- A. Syndrome de West
- B. Syndrome de Dravet
- C. Épilepsie myoclonique juvénile
- D. Épilepsie absence typique
- E. Épilepsie rolandique

Réponse : A

14. Que signifie une « crise focale » selon la classification ILAE ?

- A. Crise débutant dans un réseau limité à un hémisphère cérébral
- B. Crise impliquant les deux hémisphères simultanément
- C. Crise secondaire à un trouble métabolique
- D. Crise sans substrat cortical
- E. Crise uniquement nocturne

Réponse : A

15. Qu'est-ce qu'une « crise généralisée » selon la classification ILAE ?

- A. Crise engageant d'emblée un réseau épileptogène sur les deux hémisphères cérébraux
- B. Crise limitée à un seul lobe
- C. Crise survenant exclusivement pendant le sommeil
- D. Crise focale avec bilatéralisation
- E. Crise déclenchée par un stimulus sensoriel

Réponse : A

16. Quelle est la classification correcte des crises focales selon la conscience ?

- A. Avec conscience préservée ou altérée
- B. Simples, complexes et secondaires
- C. Partielles et totales
- D. Brèves et prolongées
- E. Moteurs et non moteurs uniquement

Réponse : A

17. Quelle catégorie de crise fait partie des crises généralisées ?

- A. Crise d'absence typique
- B. Crise temporale mésiale
- C. Crise insulaire
- D. Crise rolandique
- E. Crise pariétale

Réponse : A

18. Quelle est la classification actuelle des syndromes épileptiques selon l'ILAE (2022) ?

- A. Épilepsies focales, généralisées, focales et généralisées et indéterminées
- B. Épilepsies idiopathiques et symptomatiques
- C. Épilepsies primaires et secondaires
- D. Épilepsies motrices et sensorielles
- E. Épilepsies cryptogéniques uniquement

Réponse : A

19. Quelle est la principale différence entre une crise et un syndrome épileptique ?

- A. La crise est un événement unique, le syndrome est un ensemble clinique et électro-clinique
- B. Les deux sont synonymes
- C. Le syndrome est limité à un type de crise
- D. Le syndrome ne se voit qu'à l'âge adulte
- E. La crise dure toujours plus de 5 minutes

Réponse : A

20. Quelle épilepsie appartient au groupe des épilepsies généralisées idiopathiques ?

- A. Épilepsie myoclonique juvénile
- B. Épilepsie temporale mésiale
- C. Épilepsie frontale nocturne
- D. Épilepsie occipitale de l'enfant
- E. Épilepsie insulaire

Réponse : A

21. Que comprend l'approche de classification ILAE 2022 pour chaque patient ?

- A. Type de crise, type d'épilepsie, syndrome, étiologie et comorbidités
- B. Type de crise uniquement
- C. Âge de début et imagerie
- D. EEG seul
- E. Traitement médicamenteux

Réponse : A

22. Quel est le traitement de première intention des épilepsies focales chez l'adulte ?

- A. Lamotrigine
- B. Acide valproïque
- C. Clobazam
- D. Ethosuximide
- E. Diazépam

Réponse : A

23. Quel est le traitement de première intention d'une épilepsie focale chez l'enfant ?

- A. Carbamazépine
- B. Phénytoïne
- C. Clonazépam
- D. Ethosuximide
- E. Phénobarbital

Réponse : A

24. Quel médicament est contre-indiqué dans les épilepsies généralisées idiopathiques (EGI)?

- A. Carbamazépine
- B. Valproate de sodium
- C. Lévetiracétam
- D. Lamotrigine
- E. Topiramate

Réponse : A

25. Quel est le traitement de première intention d'une épilepsie généralisée avec absences typiques en Tunisie avant la puberté?

- A. Ethosuximide
- B. Carbamazépine
- C. Phénytoïne
- D. Valproate de sodium
- E. Gabapentine

Réponse : D

26. Quel est le traitement de première intention dans une épilepsie généralisée tonico-clonique idiopathique ?

- A. Valproate de sodium
- B. Gabapentine
- C. Vigabatrine
- D. Phénytoïne
- E. Phénobarbital

Réponse : A

27. Quel médicament est le plus efficace dans le **syndrome de West** d'origine non métabolique ?

- A. corticoïdes
- B. Valproate
- C. Carbamazépine
- D. Ethosuximide
- E. Lamotrigine

Réponse : A

28. Quel traitement est indiqué en **première intention** dans un **syndrome de West secondaire à une sclérose tubéreuse de Bourneville** ?

- A. Vigabatrine
- B. corticoïdes
- C. Phénytoïne
- D. Clobazam
- E. Lamotrigine

Réponse : A

29. Quelle molécule peut être utilisée en **deuxième intention** dans le syndrome de West après échec de corticothérapie ?

- A. Vigabatrine
- B. Phénytoïne
- C. Ethosuximide
- D. Levetiracetam
- E. Clonazépam

Réponse : A

30. Chez la femme en âge de procréer avec épilepsie généralisée, quel traitement est à éviter en première intention ?

- A. Valproate de sodium
- B. Lamotrigine
- C. Lévetiracétam
- D. Topiramate
- E. Clobazam

Réponse : A, D

31. Quel est le traitement de première intention dans une **épilepsie myoclonique juvénile** ?

- A. Valproate de sodium
- B. Carbamazépine
- C. Gabapentine
- D. Oxcarbazépine
- E. Tiagabine

Réponse : A

32. Quelle est la définition actuelle d'une **crise épileptique** selon la Ligue Internationale Contre l'Épilepsie (ILAE, 2014) ?

- A. Survenue transitoire de signes ou symptômes dus à une activité neuronale excessive ou synchrone
- B. Trouble permanent de la conscience
- C. Anomalie EEG isolée
- D. Réaction comportementale au stress
- E. Trouble métabolique passager

Réponse : A

33. Comment définit-on une **épilepsie** selon l'ILAE (2014) ?

- A. Maladie cérébrale caractérisée par la survenue d'au moins deux crises non provoquées à plus de 24 heures d'intervalle
- B. Crise unique avec risque de récurrence supérieur à 60%
- C. Activité EEG anormale sans symptômes
- D. État de mal épileptique
- E. Crise provoquée par une hypoglycémie

Réponse : A

34. Quelle est la principale caractéristique clinique d'une **crise focale avec altération de la conscience** ?

- A. Altération de la conscience avec automatisme moteur
- B. Chute immédiate avec perte de tonus
- C. Absence typique brève
- D. Myoclonies bilatérales
- E. Raideur tonique sans automatisme

Réponse : A

35. Quelle est la sémiologie électroclinique typique d'une **crise d'absence typique** ?

- A. Suspension brève du contact avec pointe-onde généralisée à 3 Hz
- B. Tremblement postural avec rythme rapide
- C. Perte de tonus musculaire prolongée
- D. Myoclonies unilatérales
- E. Activité delta focale

Réponse : A

36. Quelle manifestation clinique traduit une **crise tonique généralisée** ?

- A. Raideur musculaire bilatérale soutenue, souvent avec apnée
- B. Clonies rythmées des extrémités
- C. Perte de tonus brutale
- D. Absence de réponse motrice
- E. Automatisme oro-alimentaire

Réponse : A

37. Quelle anomalie EEG est typique d'une **crise myoclonique généralisée** ?

- A. Décharges de pointe-polypointes généralisées
- B. Pointe lente focale
- C. Activité delta rythmique temporale
- D. Complexes de pointe-ondes à 12 Hz
- E. Bouffées de rythme alpha

Réponse : A

38. Quelle est la séquence électroclinique d'une **crise tonico-clonique généralisée** ?

- A. Phase tonique (raideur) suivie de clonies bilatérales puis phase post-critique
- B. Perte de tonus immédiate
- C. Absence avec suspension du regard
- D. Myoclonies isolées sans altération de conscience
- E. Crise focale sans généralisation

Réponse : A

39. Quelle est la sémiologie électroclinique d'une **crise atonique** ?

- A. Perte soudaine du tonus musculaire, souvent avec chute, associée à un arrêt transitoire du rythme EEG
- B. silence électrique sur l'EMG
- C. chute brutale
- D. Poursuite oculaire altérée sans chute
- E. Spasmes isolés du visage

Réponse : A, B, C

40. Quel est le **corrélat EEG** le plus fréquent d'une **crise focale motrice** ?

- A. Décharges de pointes recrutantes, souvent frontales ou rolandiques
- B. Activité généralisée symétrique
- C. Rythme alpha postérieur
- D. Activité delta diffuse
- E. Décharges occipitales lentes

Réponse : A

41. Quelle est la différence principale entre **crise** et **syndrome épileptique** sur le plan électroclinique ?

- A. La crise est un événement isolé, le syndrome regroupe des types de crises, une étiologie et un profil EEG spécifique
- B. Le syndrome est une seule crise prolongée
- C. Le syndrome n'a pas de corrélation EEG
- D. La crise n'a pas de manifestation clinique
- E. Le syndrome est toujours focal

Réponse : A

42. Un adolescent de 15 ans est observé en classe avec des épisodes brefs d'interruption de son activité, durant quelques secondes, sans chute, ni confusion post-critique. L'EEG intercritique montre des bouffées de pointes-ondes généralisées à 3 Hz.

Quelles affirmations sont correctes ?

- A. Il s'agit probablement de crises d'absence typiques.
- B. Ces crises relèvent d'une épilepsie généralisée idiopathique.
- C. Ces crises ont un début focal temporal.
- D. Un traitement par carbamazépine est le plus approprié.
- E. Ces crises peuvent être aggravées par l'hyperventilation.

Réponse : A,B,E

43. Un patient adulte présente des crises débutant par une sensation étrange épigastrique, suivie d'un comportement automatique (mâchonnement), et d'une confusion post-critique.

Quelles propositions sont exactes ?

- A. Il s'agit d'une crise focale avec altération de la conscience.
- B. Le lobe temporal est probablement le foyer épileptogène.
- C. La crise est classée comme généralisée d'emblée.
- D. L'EEG peut montrer une activité rythmique focale temporale.
- E. La crise ne nécessite aucun traitement anticomitial.

Réponse : A,B,D

44. Un enfant de 6 ans présente des crises nocturnes avec déviation oculaire, clonies faciales unilatérales, parfois avec trouble de la parole. L'EEG montre des pointes centro-temporales. **Que peut-on conclure ?**

- A. Il s'agit probablement d'une épilepsie à pointes centro-temporales bénigne (Rolandique).
- B. Cette forme d'épilepsie nécessite un traitement à vie.
- C. La crise est de type focale.
- D. Cette épilepsie est associée à un bon pronostic.
- E. Elle correspond à une crise généralisée idiopathique.

Réponse : A,C,D

45. Quelle est la définition d'une **crise fébrile simple** ?

- A. Crise généralisée survenant chez l'enfant de 6 mois à 5 ans, en contexte fébrile, durant moins de 15 minutes, sans déficit post-critique
- B. Crise focale prolongée associée à une infection cérébrale
- C. Crise répétée dans les 24 heures
- D. Crise survenant sans fièvre
- E. Crise survenant après 10 ans

Réponse : A

46. Quelle est la caractéristique d'une **crise fébrile complexe** ?
- A. Durée > 15 minutes ou caractère focal ou récidive dans les 24 heures
 - B. Crise brève et généralisée
 - C. Crise liée à un trouble métabolique
 - D. Crise sans fièvre
 - E. Crise unique chez un nourrisson

Réponse : A

47. Quelle est la prise en charge immédiate d'une **crise fébrile prolongée** ?
- A. Administration de diazépam rectal ou midazolam buccal
 - B. Observation simple sans traitement
 - C. Antibiothérapie systématique
 - D. IRM cérébrale en urgence
 - E. Perfusion de glucose

Réponse : A

48. Quelle est la définition d'une **crise symptomatique aiguë** ?
- A. Crise survenant en lien temporel direct avec une agression cérébrale aiguë (infection, AVC, traumatisme, désordre métabolique)
 - B. Crise sans cause identifiable
 - C. Crise récurrente sans fièvre
 - D. Crise chronique réfractaire
 - E. Crise liée à un médicament

Réponse : A

49. Quelle est la différence entre **crise fébrile** et **crise symptomatique aiguë** ?
- A. La crise fébrile survient sans atteinte cérébrale aiguë, la crise symptomatique est liée à une lésion ou un trouble aigu
 - B. Les deux sont identiques
 - C. La crise fébrile est toujours focale
 - D. La crise symptomatique ne nécessite jamais d'exploration
 - E. La crise fébrile est toujours prolongée

Réponse : A

50. Quel médicament anticrise épileptique est le plus souvent responsable de **prise de poids** ?
- A. Valproate de sodium
 - B. Lamotrigine
 - C. Topiramate
 - D. Zonisamide
 - E. Lévetiracétam

Réponse : A

51. Quel médicament anticrise épileptique peut provoquer une **éruption cutanée sévère (syndrome de Stevens-Johnson)** ?

- A. Lamotrigine
- B. Valproate
- C. Gabapentine
- D. Levetiracetam
- E. Vigabatrine

Réponse : A

52. Quel médicament anticrise épileptique expose à un risque de **toxicité hépatique** chez le nourrisson ?

- A. Valproate de sodium
- B. Phénytoïne
- C. Carbamazépine
- D. Ethosuximide
- E. Clonazépam

Réponse : A

53. Quel effet indésirable est fréquent sous **lévétiracétam** ?

- A. Irritabilité et troubles du comportement
- B. Prise de poids importante
- C. Alopécie
- D. Hypotension sévère
- E. Hépatotoxicité

Réponse : A

54. Quel médicament anticrise épileptique est connu pour induire une **lithiase rénale** ?

- A. Topiramate
- B. Lamotrigine
- C. Valproate
- D. Carbamazépine
- E. Phénytoïne

Réponse : A

55. Quel est l'objectif principal de la **surveillance du traitement** anticrise épileptique ?

- A. Optimiser l'efficacité tout en limitant les effets indésirables
- B. Déterminer la cause de l'épilepsie
- C. Remplacer le traitement par une chirurgie
- D. Supprimer l'EEG anormal
- E. Réduire les coûts de traitement

Réponse : A

56. Quelle est la principale utilité du **dosage plasmatique des** médicaments anticrises épileptiques ?

- A. Vérifier l'observance et adapter la posologie en cas d'efficacité insuffisante ou d'effets indésirables
- B. Diagnostiquer un type d'épilepsie
- C. Contrôler la fonction rénale uniquement
- D. Déterminer le type de crise
- E. Prédire la guérison

Réponse : A

57. À quel moment le **dosage plasmatique du valproate** doit-il être effectué ?

- A. Juste avant la prise suivante (taux résiduel)
- B. Immédiatement après la prise
- C. En période de crise
- D. Après 24 heures d'arrêt
- E. Au hasard

Réponse : A

58. Quelle précaution est nécessaire lors de l'instauration d'une **polythérapie** anticrise épileptique ?

- A. Surveiller les interactions médicamenteuses et les effets cumulés
- B. Doubler les doses initiales
- C. Arrêter le traitement de fond
- D. Ne pas surveiller les taux plasmatiques
- E. Supprimer le suivi clinique

Réponse : A

59. Quelle surveillance biologique est recommandée sous **valproate de sodium** ?

- A. Fonction hépatique et numération plaquettaire
- B. Tension artérielle
- C. Glycémie
- D. Taux de calcium
- E. Hémocultures

Réponse : A

60. Quelle est la principale mesure d'**éducation thérapeutique** chez un patient épileptique ?

- A. Comprendre la maladie, reconnaître les crises et respecter le traitement
- B. Apprendre à interrompre le traitement dès amélioration
- C. Éviter toute activité physique
- D. Cacher la maladie à l'entourage
- E. Se fier uniquement à l'EEG

Réponse : A

61. Quelle recommandation doit être donnée concernant la **conduite automobile** chez un patient épileptique ?

- A. Interdiction temporaire jusqu'à une période d'au moins 1 an sans crise
- B. Autorisation immédiate après traitement
- C. Aucun contrôle requis
- D. Conduite possible pendant les crises mineures
- E. Décision laissée au patient

Réponse : A

62. Quelle attitude adopter face à un patient présentant des **troubles cognitifs ou psychiatriques sous traitement** ?

- A. Réévaluer le traitement et envisager une substitution médicamenteuse
- B. Doubler la dose
- C. Arrêter brutalement le traitement
- D. Ne rien modifier
- E. Associer un anxiolytique systématiquement

Réponse : A

63. Quelle est la **durée minimale de traitement antiépileptique** avant d'envisager un sevrage après contrôle complet des crises ?

- A. 2 à 5 ans sans crise selon le type d'épilepsie
- B. 6 mois sans crise
- C. 1 an sans crise
- D. 10 ans systématiques
- E. Dès normalisation de l'EEG

Réponse : A

64. Quel rôle joue l'**éducation thérapeutique des parents** dans l'épilepsie de l'enfant ?

- A. Reconnaître les crises, administrer les traitements d'urgence et éviter les facteurs déclenchants
- B. Décider des posologies
- C. Choisir le médicament anticrise épileptique
- D. Supprimer les activités scolaires
- E. Interdire toute autonomie

Réponse : A

